



FORMULÁRIO ESPECÍFICO – HAP

1	NOME CIVIL DO(A) PACIENTE: Maria da Silva Santos NOME SOCIAL DO(A) PACIENTE:												
2	DATA DE NASCIMENTO: 22 / 08 / 1975												
3	CID-10: I27.0												
4	4.1 HIPERTENSÃO PULMONAR – INDICAR GRUPO: ☒ I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V 4.2 INFORMAR: <table><tr><td>Paciente possui fatores de risco ou dados ecocardiográficos compatíveis com doenças do coração esquerdo como causa de HP?</td><td>SIM ☒ NÃO ☐</td></tr><tr><td>Paciente possui exames compatíveis com doenças pulmonares crônicas como causa de HP?</td><td>SIM ☐ NÃO ☒</td></tr><tr><td>Paciente possui exames compatíveis com embolia pulmonar como causa de HP?</td><td>SIM ☐ NÃO ☒</td></tr></table>	Paciente possui fatores de risco ou dados ecocardiográficos compatíveis com doenças do coração esquerdo como causa de HP?	SIM ☒ NÃO ☐	Paciente possui exames compatíveis com doenças pulmonares crônicas como causa de HP?	SIM ☐ NÃO ☒	Paciente possui exames compatíveis com embolia pulmonar como causa de HP?	SIM ☐ NÃO ☒						
Paciente possui fatores de risco ou dados ecocardiográficos compatíveis com doenças do coração esquerdo como causa de HP?	SIM ☒ NÃO ☐												
Paciente possui exames compatíveis com doenças pulmonares crônicas como causa de HP?	SIM ☐ NÃO ☒												
Paciente possui exames compatíveis com embolia pulmonar como causa de HP?	SIM ☐ NÃO ☒												
5	CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E EVOLUÇÃO DA DOENÇA: Paciente com dispneia progressiva aos médios esforços há 2 anos, com piora nos últimos 6 meses. Exame físico: P2 hiperfonética, sem edema.												
6	CATETERISMO CARDÍACO DIREITO: Data: 10 / 03 / 2026 <table><tr><td>☐ PAPm:</td><td> 42 </td></tr><tr><td>☒ POAP ou PDFVE:</td><td> 10 </td></tr><tr><td>☐ RVP Wood:</td><td> 8,5 </td></tr></table> PAPm: pressão arterial pulmonar média; POAP: pressão de oclusão da artéria pulmonar; PDFVE: pressão diastólica final do ventrículo esquerdo; RVP: resistência vascular pulmonar	☐ PAPm:	42	☒ POAP ou PDFVE:	10	☐ RVP Wood:	8,5						
☐ PAPm:	42												
☒ POAP ou PDFVE:	10												
☐ RVP Wood:	8,5												
7	INFORMAR ETIOLOGIA DA DOENÇA: ☒ 7.1 HAP Idiopática, hereditária ou induzida por drogas. 7.1.1 Caso assinalado o item acima, indicar: TESTE DE REATIVIDADE COM ÓXIDO NÍTRICO: ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO Justificativa para não realização do teste: OU ☐ 7.2 HAP associada 7.2.1 Caso assinalado o item acima, indicar enfermidade associada: <table><tr><td>☐</td><td>Colagenoses,</td></tr><tr><td>☐</td><td>Hipertensão Porto-pulmonar</td></tr><tr><td>☐</td><td>Esquistossomose</td></tr><tr><td>☐</td><td>HIV</td></tr><tr><td>☐</td><td>Cardiopatia congênita</td></tr><tr><td>☐</td><td>Veno-oclusiva</td></tr></table>	☐	Colagenoses,	☐	Hipertensão Porto-pulmonar	☐	Esquistossomose	☐	HIV	☐	Cardiopatia congênita	☐	Veno-oclusiva
☐	Colagenoses,												
☐	Hipertensão Porto-pulmonar												
☐	Esquistossomose												
☐	HIV												
☐	Cardiopatia congênita												
☐	Veno-oclusiva												



8	MEDICAMENTOS SOLICITADOS: <table border="1"><thead><tr><th>Medicamentos solicitado</th><th>Posologia</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒ Ambrisentana</td><td>Ambrisentana 5mg — 1 comprimido ao dia</td></tr><tr><td>☐ Bosentana</td><td></td></tr><tr><td>☒ Sildenafil</td><td>Sildenafil 20mg — 1 comprimido 3x ao dia</td></tr><tr><td>☐ Iloprosta</td><td></td></tr></tbody></table>	Medicamentos solicitado	Posologia	☒ Ambrisentana	Ambrisentana 5mg — 1 comprimido ao dia	☐ Bosentana		☒ Sildenafil	Sildenafil 20mg — 1 comprimido 3x ao dia	☐ Iloprosta	
Medicamentos solicitado	Posologia										
☒ Ambrisentana	Ambrisentana 5mg — 1 comprimido ao dia										
☐ Bosentana											
☒ Sildenafil	Sildenafil 20mg — 1 comprimido 3x ao dia										
☐ Iloprosta											
9	RISCO ESTRATIFICADO (CONFORME PCDT): ☐ RISCO BAIXO ☒ RISCO INTERMEDIÁRIO ☐ RISCO ALTO Detalhar: Paciente em acompanhamento regular a cada 3 meses. Solicitação de renovação conforme PCDT HAP.										
10	CLASSE FUNCIONAL (NYHA/WHO-FC): ☐ I ☐ II ☒ III ☐ IV										
11	O PACIENTE APRESENTA ALGUMA DAS SITUAÇÕES DESCRITAS ABAIXO? <table border="1"><tbody><tr><td>Doença hepática grave</td><td>SIM ☐ NÃO ☒</td></tr><tr><td>Suspeita ou alta probabilidade de doença pulmonar venoclusiva ou hemangiomatose pulmonar capilar</td><td>SIM ☐ NÃO ☒</td></tr><tr><td>Paciente com HAP-I > 75 anos e com múltiplos fatores de risco para insuficiência cardíaca com FE preservada (hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito, doença arterial coronariana, fibrilação atrial, obesidade)</td><td>SIM ☐ NÃO ☒</td></tr><tr><td>Paciente com HAP que permanecem estáveis e estratificados com baixo risco após tratamento prolongado (>5-10 anos) com monoterapia</td><td>SIM ☐ NÃO ☒</td></tr><tr><td>Paciente com HAP-I, HAP-H ou HAP-D com teste de vasorreatividade pulmonar positivo em classe funcional I-II e resposta hemodinâmica sustentada após 1 ano de BCC</td><td>SIM ☐ NÃO ☒</td></tr></tbody></table>	Doença hepática grave	SIM ☐ NÃO ☒	Suspeita ou alta probabilidade de doença pulmonar venoclusiva ou hemangiomatose pulmonar capilar	SIM ☐ NÃO ☒	Paciente com HAP-I > 75 anos e com múltiplos fatores de risco para insuficiência cardíaca com FE preservada (hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito, doença arterial coronariana, fibrilação atrial, obesidade)	SIM ☐ NÃO ☒	Paciente com HAP que permanecem estáveis e estratificados com baixo risco após tratamento prolongado (>5-10 anos) com monoterapia	SIM ☐ NÃO ☒	Paciente com HAP-I, HAP-H ou HAP-D com teste de vasorreatividade pulmonar positivo em classe funcional I-II e resposta hemodinâmica sustentada após 1 ano de BCC	SIM ☐ NÃO ☒
Doença hepática grave	SIM ☐ NÃO ☒										
Suspeita ou alta probabilidade de doença pulmonar venoclusiva ou hemangiomatose pulmonar capilar	SIM ☐ NÃO ☒										
Paciente com HAP-I > 75 anos e com múltiplos fatores de risco para insuficiência cardíaca com FE preservada (hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito, doença arterial coronariana, fibrilação atrial, obesidade)	SIM ☐ NÃO ☒										
Paciente com HAP que permanecem estáveis e estratificados com baixo risco após tratamento prolongado (>5-10 anos) com monoterapia	SIM ☐ NÃO ☒										
Paciente com HAP-I, HAP-H ou HAP-D com teste de vasorreatividade pulmonar positivo em classe funcional I-II e resposta hemodinâmica sustentada após 1 ano de BCC	SIM ☐ NÃO ☒										



12 EXAMES COMPLEMENTARES:

Exames complementares	Data	Resultado
Ecocardiograma	15/02/2026	PSAP estimada 65 mmHg, VD dilatado e hipocinético, IT moderada
Eletrocardiograma	15/02/2026	Desvio do eixo para a direita, sobrecarga de VD
Espirometria	20/01/2026	Padrão obstrutivo leve (VEF1/CVF 68%)
Teste de caminhada de 6 minutos (T6MC)	05/03/2026	320 metros (previsto 580 m), SpO2 mínima 89%
Polissonografia/Oximetria Noturna*	15/01/2026	IAH 3/h — sem SAOS significativa
Angiotomografia de tórax ou Cintilografia Pulmonar de Perfusão	20/02/2026	Sem sinais de TEP crônico
Ultrassonografia abdominal	10/01/2026	Fígado com textura heterogênea, sem sinais de HPP
Gasometria arterial	10/03/2026	pH 7,42 / PaO2 72 mmHg / PaCO2 34 mmHg / SatO2 94%
Radiografia de Tórax	20/02/2026	Alargamento do tronco pulmonar, hilos aumentados

Nyha: new york heart association. Who: world health organization. Fc: functional classification

* Reservado aos pacientes com sintomatologia da síndrome da apneia, hipopneia obstrutiva do sono (sahos).

13 OUTRAS OBSERVAÇÕES PERTINENTES:

14 Assumo integral responsabilidade pela veracidade das informações prestadas.

Data de preenchimento: 19 / 05 / 2026

Assinatura e carimbo: _____

Médico